

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE VON 1980 BERLIN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 23	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ (2013)	

Durchführende:

- Pflegefachkraft (PFK) und Pflegehilfskraft (PHK)

Definition, erhöhtes Sturzrisiko:

„Jeder Mensch hat ein Risiko zu stürzen, sei es durch Unachtsamkeit oder bei einer sportlichen Betätigung. Über dieses alltägliche Risiko hinaus gibt es Stürze, deren Ursache im Verlust der Fähigkeit zur Vermeidung eines Sturzes liegt.“ (Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“, 1. Aktualisierung 2013)

Pflegeziel:

Jeder Patient mit einem erhöhten Sturzrisiko erhält eine Sturzprophylaxe, die Stürze weitgehend verhindert und Sturzfolgen minimiert.

personenbezogene Risikofaktoren

Beeinträchtigung funktioneller Fähigkeiten bspw. Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens, Beeinträchtigung sensomotorischer Funktionen bspw. Einschränkungen der Gehfähigkeit oder Balancestörungen, Gesundheitsstörungen, die mit Schwindel, kurzzeitigem Bewusstseinsverlust oder ausgeprägter körperlicher Schwäche einhergehen, Depression und kognitive Beeinträchtigungen, Kontinenzprobleme, Sehbeeinträchtigungen, Sturzangst, Stürze in der Vorgeschichte

Medikamentenbezogene Sturzrisikofaktoren

Antihypertensiva (blutdrucksenkende Mittel), Polypharmazie (mehr als 4 verschiedene Medikamente), Psychotrope Medikamente (bspw. Psychopharmaka)

Umgebungsbezogene Sturzrisikofaktoren

freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM), unangepasstes Schuhwerk, Gefahren in der Umgebung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung durch den Patienten

Vorbereitung:

- Hände waschen
- Patient, ggf. Angehörige informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Durchführung:

- die erste pflegefachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu den individuellen pflegesensitiven Risiken und Phänomenen (ja-nein) ergibt sich aus den Erkenntnissen der Situationseinschätzung in den Themenfeldern durch die PFK unter der Rubrik relevantes Risiko und Phänomen in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS).
- Wird die Kategorie von der PFK mit „nein“ angekreuzt liegt aus pflegefachlicher Sicht kein Sturzrisiko vor, es werden keine prophylaktischen Maßnahmen geplant und umgesetzt.
- Wird die Kategorie „ja“ angekreuzt, muss die PFK zusätzlich eine Entscheidung zu der Kategorie „weitere Einschätzung notwendig“ (ja-nein) treffen, um festzulegen, ob hierzu aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit für die Maßnahmenplanung besteht. Für die Bewertung sind die dargestellten Risiken und Ursachen des aktuellen Nationalen Expertenstandards heranzuziehen.
- tritt Sturzgefahr als Phänomen später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtsblatt und die Anpassung der Maßnahmenplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./IMA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AN DER UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 23	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ (2013)	

- ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben und auf der SIS angekreuzt, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen
- das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist zu beachten, bei Einbindung von Angehörigen ist vorher die Genehmigung durch den Patienten einzuholen

Maßnahmen der Sturzprophylaxe können sein:

- Patienten und Angehörige sind über Sturzrisiken aufzuklären und zu beraten
- Feststellung von Vorlieben bzw. Ablehnungen im Rahmen der Umsetzung sturzprophylaktischer Maßnahmen
- externe Personen wie der Arzt/Augenarzt bzw. Physiotherapeut/Ergotherapeut sind über das Sturzrisiko zu informieren, zu weiteren individuell notwendigen Maßnahmen ist sich abzustimmen
- Die PFK koordiniert notwendige Aktivitäten mit Dritten und informiert bei Notwendigkeit die PDL
- im Rahmen des Entlassungsmanagement in andere Versorgungsformen ist auf das Sturzrisiko hinzuweisen (prophylaktische Maßnahmen oder ggf. zu unterlassende Maßnahmen)
- der Patient/Angehörige ist bei der Umsetzung zu unterstützen
- Beobachtung und pflegfachliche Bewertung von Beinahe-Stürzen
- Nutzung aller Möglichkeiten der Förderung von Mobilität (bspw. innerhalb pflegerischer Maßnahmen, zusätzliche Betreuungsleistungen, Einbeziehung von Angehörigen etc.)
- Schaffung der Möglichkeit zur Teilnahme an Kursen zur Förderung von Kraft und Balance, Durchführung multimedialer bzw. multimodularer Kurse (aus verschiedenen Komponenten zusammenhängendes Training über einen längeren Zeitraum), intern/extern
- Anregung zur Überprüfung und Anpassung der Medikation durch den Arzt, Anwendung der „10-R-Regel zur qualitätsgesicherten Medikamentengabe“
- Verbesserung der Sehfähigkeit, Unterstützung bei der Anpassung von neuen Brillen bzw. Gläsern
- Die PFK empfiehlt mögliche Anpassungen der Umgebung z. B. Überprüfung und Anpassung der Lichtverhältnisse, der Sitzmöbel, des Bettes, der Toilette, der Dusche oder Badewanne und des Fußbodens sowie das Anbringen von Haltegriffen, Beseitigung von Stolperfallen, Einsatz geeigneter Hilfsmittel, Benutzung rutschfester Unterlagen
- **Hilfsmittel zur Sturzprävention könnten sein:**
Gehhilfen: verschiedene Gehstöcke, Rollatoren, Stoppersocken, Schuhspikes,
Mobilitätshilfen: höhenverstellbares Bett, WC-Sitzerhöhung, Badewannen-Einstiegshilfe, Stütz- und Haltegriffe
Alltagshilfen: lange Schuhlöffel, Strumpfanzieher, Greifzange, Badewannensitz
Hebehilfen: Mobilisationsgürtel, Rutschbrett, Aufstieghilfe, Lifter
technische Hilfen: Alarmgeber, Falldetektoren, Sensormatten, Bewegungsmelder
Reduktion von Verletzungen: Hüftprotektoren, Sturzhelme, Niedrigstbetten, Auffangmatten
- Anbieten von Schulungen/ Einweisungen in die bewusste und ordnungsgemäße Handhabung von Hilfsmitteln (bspw. Rollatoren und andere Hilfsmittel etc.)
- Anpassung Schuhwerk, Empfehlungen für besonderes Schuhwerk
- Unterstützung bei Toilettengängen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE Kliniken · Ambulanzen · Pflegeheimen
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 23	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ (2013)	

- im Ausnahmefall kann es im Rahmen der Sturzprophylaxe auch zum bewussten Einsatz freiheitseinschränkender/freiheitsentziehender Maßnahmen kommen, hierbei ist nach dem hierfür geltenden Standard zu verfahren – besitzt der Patient keine Eigenbewegung mehr kann das Ziehen des Bettgitters als Maßnahme der Sturzprophylaxe geplant werden ansonsten ist der Einsatz von FEM im Rahmen der Sturzprophylaxe nicht zulässig

nach einem Sturz:

- der Patient ist anzusprechen, die Vitalzeichen sind zu erheben, lebensrettende Maßnahmen sind umzusetzen
- bei Notwendigkeit sofort den Notarzt verständigen
- es ist ein Sturzprotokoll zu führen und umgehend an die PDL weiter zu leiten, die Sturzrisikoskala ist zu aktualisieren
- die PDL führt eine Gesamtliste der Sturzereignisse mit der Darstellung von Umständen und Folgen von Stürzen im Pflegedienst, mindestens einmal jährlich wertet die PDL die Gesamterhebung aus und stellt im Rahmen des PDCA-Zyklus mögliche Verbesserungsmaßnahmen dar

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. die diensthabende PFK

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA